



Rafael

Rafael está caído no campo de futebol, sujo, sem falar coisa com coisa. Os meninos da escola estão passando e rindo. Rafael tem 29 anos e vive com a avó desde os 12, quando a mãe morreu de complicações ligadas ao uso de *crack*.

Faz bicos em obras, cuida de carros, desaparece por dias. Aparece para tomar café, pedir um banho, cortar o cabelo. Nos últimos meses, passou a dormir na rua com mais frequência. Quando bebe, chora muito. Quando fuma pedra, some. Quando volta, vem em silêncio.

Naquela manhã, a técnica de referência foi até lá com o agente comunitário de saúde. Antes de qualquer coisa, fizeram uma avaliação rápida de risco: olharam se ele estava respirando bem, se respondia quando chamado, se havia sinais de queda, de batida na cabeça, se estava confuso.

A cena apontava para possível intoxicação aguda pelo uso de álcool e outras drogas, mas também levantava a suspeita de alguma complicação mais grave do uso crônico – como a encefalopatia de Wernicke, que pode manifestar com confusão intensa, dificuldade de ficar em pé e alterações do olhar.

A agente comunitária não sabia o que era a encefalopatia de Wernicke, mas a técnica de referência tinha visto no CAPS, participou de discussões com outros profissionais e soube avaliar minimamente. Diante disso, a equipe já identifica a necessidade de acionar o SAMU ou a UPA do território para avaliação clínica mais completa, incluindo o uso de tiamina parenteral e outros cuidados conforme os protocolos.

Ao lado dessa atenção ao risco físico imediato, havia também uma escolha de postura. Eles não chegaram a fazer interrogatório, nem ameaçaram uma internação. Sentaram-se no chão do campo, perto dele. “Oi, Rafael. Quer voltar para a casa da vó?” Rafael não respondeu. Chorou. “Então a gente vai com você.”